



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

MESURER

& AMÉLIORER LA QUALITÉ

RAPPORT DE CERTIFICATION

HOPITAUX ARMAND TROUSSEAU & LA ROCHE GUYON - AP-HP SORBONNE UNIVERSITE

26 AVENUE DU DR ARNOLD NETTER
75571 Paris



Validé par la HAS en Septembre 2022

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr



Haute Autorité de santé – Service communication et information
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00
© Haute Autorité de santé – Septembre 2022

Sommaire

Préambule	4
Décision	7
Présentation	8
Champs d'applicabilité	9
Résultats	10
Chapitre 1 : Le patient	11
Chapitre 2 : Les équipes de soins	13
Chapitre 3 : L'établissement	16
Table des Annexes	20
Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche	21
Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2022	22
Annexe 3. Programme de visite	23

Préambule

La certification, mission confiée à la Haute Autorité de Santé (HAS) par les ordonnances de 1996, est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des professionnels (des pairs) mandatés par la HAS : les experts-visiteurs. Cette procédure quadri-annuelle, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, porte sur le niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés aux patients. Obligatoire, elle est codifiée à l'article L6113-3 (et suivants) du code de la santé publique.

La certification constitue une des modalités de mesure de la qualité des soins en établissements de santé et vise l'appropriation des standards de la qualité par les établissements. Elle y favorise également la mise en œuvre d'une dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elle est une certification globale et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le dispositif porte sur le fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à évaluer spécifiquement le fonctionnement de chaque secteur d'activité.

Elle fournit une évaluation de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé aux usagers et aux Agences régionales de santé (ARS) sans se substituer aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire menés par ces autorités de tutelle.

Cette démarche nationale est réalisée selon des standards internationaux : la procédure de certification est elle-même évaluée par l'International Society for Quality in Health Care via l'International Accreditation Program (IAP), le seul programme international qui accrédite les organismes qui accréditent des structures de soins. La HAS a obtenu de l'ISQua en 2018 le renouvellement de son accréditation pour son activité de certification.

Une évaluation qui s'appuie sur un référentiel élaboré par la HAS en concertation avec les professionnels de santé, les organisations représentatives et les représentants des usagers...

Chaque établissement de santé est évalué sur les critères génériques, s'appliquant à tout l'établissement, ainsi que sur des critères spécifiques relevant :

- de populations spécifiques : enfant et adolescent, patient âgé, personne en situation de handicap,
- de modes de prise en charge spécifiques : ambulatoire, hospitalisation à domicile (HAD), SAMU-SMUR, urgences, soins critiques (soins continus, soins intensifs et réanimation)
- de secteurs d'activités spécifiques : chirurgie et interventionnel, maternité, psychiatrie et santé mentale, soins de suite et de réadaptation (SSR), unité de soins de longue durée (USLD).

Ce référentiel, publié sur le site Internet de la HAS, comprend des critères ayant des niveaux d'exigence différents :

- des critères standards correspondent aux attendus de la certification;
- des critères impératifs correspondent à ce que l'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Ils ont un impact particulier dans la décision de certification. En effet, si une évaluation de l'un de ces critères est négative pour un ou plusieurs de ses éléments d'évaluation, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement.
- des critères avancés correspondent à des exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour. Ils correspondent potentiellement aux critères de certification de demain et sont valorisés pour les établissements qui peuvent y répondre sous condition d'un niveau minimal sur l'ensemble des critères standards et impératifs.

| ... et sur des méthodes

- des patients traceurs pour évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge d'un patient dans l'établissement de santé
- des parcours traceurs pour évaluer la continuité et la coordination de la prise en charge des patients, le travail en équipe et la culture qualité et sécurité au cours d'un parcours de soins défini
- des traceurs ciblés pour évaluer la mise en œuvre d'un processus ciblé
- des audits systèmes pour évaluer les organisations de l'établissement et s'assurer de leur maîtrise sur le terrain
- des observations pour évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité des soins.

| Un rapport de certification structuré en 3 chapitres

Les résultats des évaluations réalisées durant une visite de l'établissement par des experts-visiteurs se traduisent dans un rapport de visite articulé en cohérence avec les 3 chapitres du référentiel.:

- Le premier chapitre concerne directement le résultat pour le patient. Tout au long de sa prise en charge, ses droits sont respectés, ses besoins spécifiques pris en compte de la même façon que ses attentes et ses préférences. Au-delà, l'engagement du patient est recherché. Son implication comme partenaire de sa prise en charge, tout comme celle de ses proches et aidants, est favorisée par l'expression de son point de vue sur son expérience et le résultat des soins.
- Le deuxième chapitre concerne les équipes de soins, à tous les niveaux. La certification vise à apprécier leur capacité à rechercher la pertinence, l'efficacité et la sécurité des soins, à se concerter et se coordonner tout au long du parcours du patient. Elle met également l'accent sur la maîtrise des risques liés au soin. Les analyses des événements indésirables associés aux soins, notamment les événements indésirables graves ainsi que des rapports de certification précédents conduisent à mettre un accent particulier sur le risque infectieux et le risque lié aux médicaments.
- Le troisième chapitre concerne l'établissement et sa gouvernance (direction et commission/conférence médicale d'établissement). Cette dernière favorise l'insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l'offre de soins et médico-sociale. Elle impulse une dynamique forte d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui associe et soutient les équipes, ainsi que les patients, représentants d'usagers et associations de malades.

Cette structuration permet l'analyse croisée entre le résultat pour le patient, les pratiques mises en œuvre par les équipes de soins et la dynamique impulsée par la gouvernance de l'établissement et du groupement, le cas échéant.

| Une décision et un rapport rendus publics

Sur la base du rapport de visite, complété d'éventuelles fiches d'anomalies et des observations de l'établissement, la HAS adopte le rapport de certification et rend une décision. La HAS peut prononcer trois types de décision :

- une décision de certification valable quatre ans qu'elle peut assortir d'une mention ;
- une décision de non-certification impliquant la mise en œuvre d'une nouvelle procédure dans un délai maximum de deux ans ;
- une décision de certification sous conditions ; une nouvelle procédure est alors programmée dans un délai compris entre six et douze mois. À l'issue de cette seconde procédure, la HAS constate si l'établissement a rempli les conditions pour être certifié. Elle prononce alors une décision de certification, avec ou sans mention, ou une décision de non-certification.

Le rapport et la décision sont publiés sur le site Internet de la HAS et communiqués à l'autorité de tutelle de l'établissement.

L'établissement doit en assurer la plus large diffusion interne. Il doit notamment la porter à la connaissance des instances délibérantes, de la commission ou conférence médicale d'établissement et de la commission des usagers.

Ce rapport de visite est produit par l'équipe des experts-visiteurs dans un délai d'une quinzaine de jour après la fin des évaluations et de la réunion de restitution, il est transmis à l'établissement pour que celui-ci puisse formuler ses observations. Il sera remis également à la HAS et fera partie des éléments de référence pour l'élaboration du rapport de certification

Décision

Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé décide la certification de l'établissement.

Présentation

HOPITAUX ARMAND TROUSSEAU & LA ROCHE GUYON - AP-HP SORBONNE UNIVERSITE	
Adresse	26 AVENUE DU DR ARNOLD NETTER 75571 Paris Cedex 12 FRANCE
Département / Région	Paris / Ile-de-france
Statut	Public
Type d'établissement	CHU / CHR

Établissement(s) juridique(s) rattaché(s) à cette démarche (la liste des établissements géographiques se trouve en annexe 1)

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	750712184	ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PARIS	3 AVENUE VICTORIA 75184 PARIS CEDEX 04 FRANCE

Synthèse des activités réalisées par l'établissement au 2022

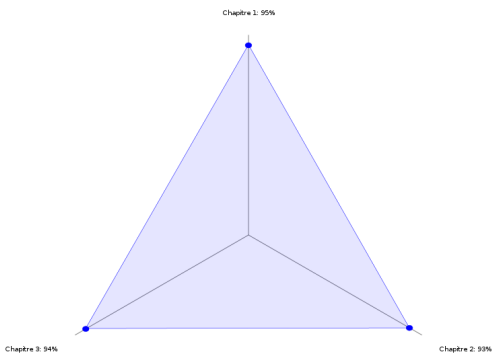
Vous trouverez en annexe 2 l'ensemble des activités réalisées par l'établissement.

Champs d'applicabilité

Champs d'applicabilité
Adulte
Ambulatoire
Chirurgie et interventionnel
Enfant et adolescent
Hospitalisation complète
Maladie chronique
Maternité
Médecine
Pas de situation particulière
Patient atteint d'un cancer
Patient en situation de handicap
Patient en situation de précarité
Programmé
Soins critiques
Soins de suite et réadaptation
Tout l'établissement
Urgences

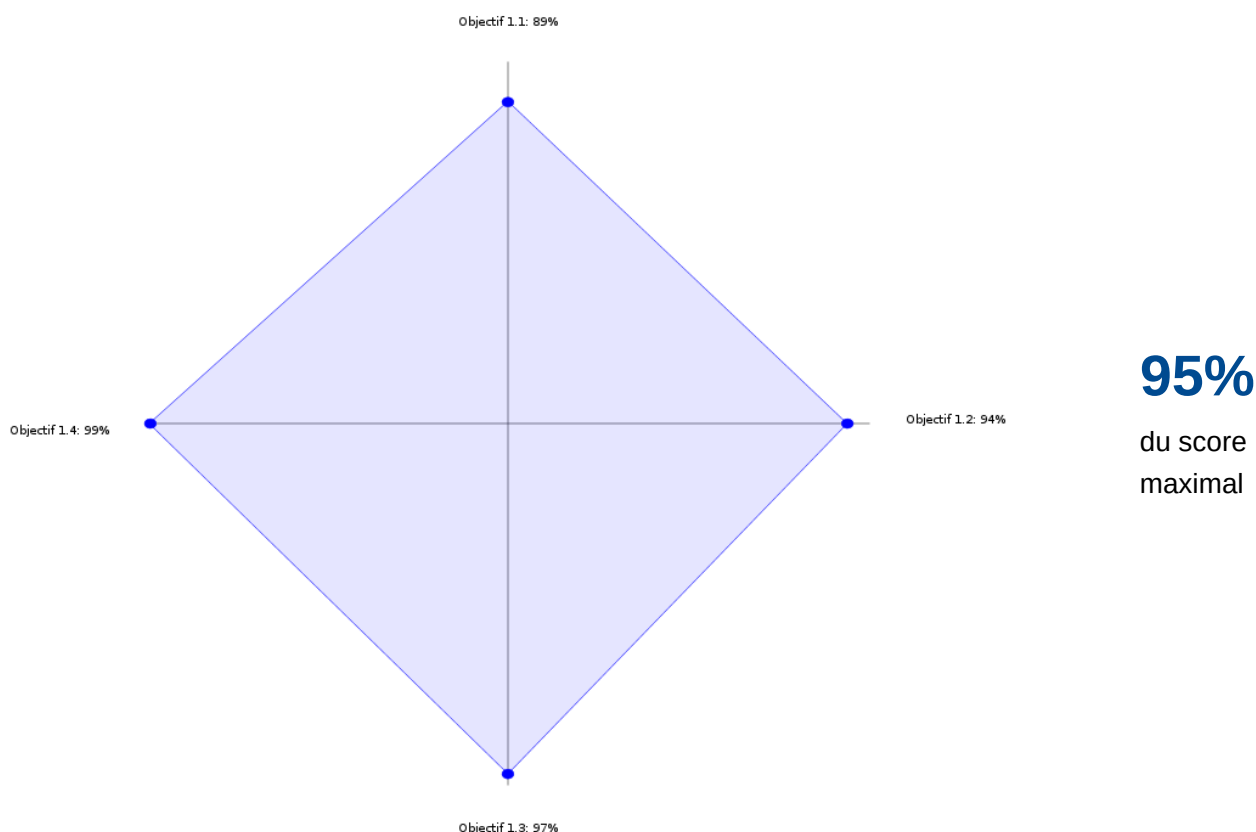
Au regard du profil de l'établissement, [113](#) critères lui sont applicables

Résultats



Chapitre	
Chapitre 1	Le patient
Chapitre 2	Les équipes de soins
Chapitre 3	L'établissement

Chapitre 1 : Le patient

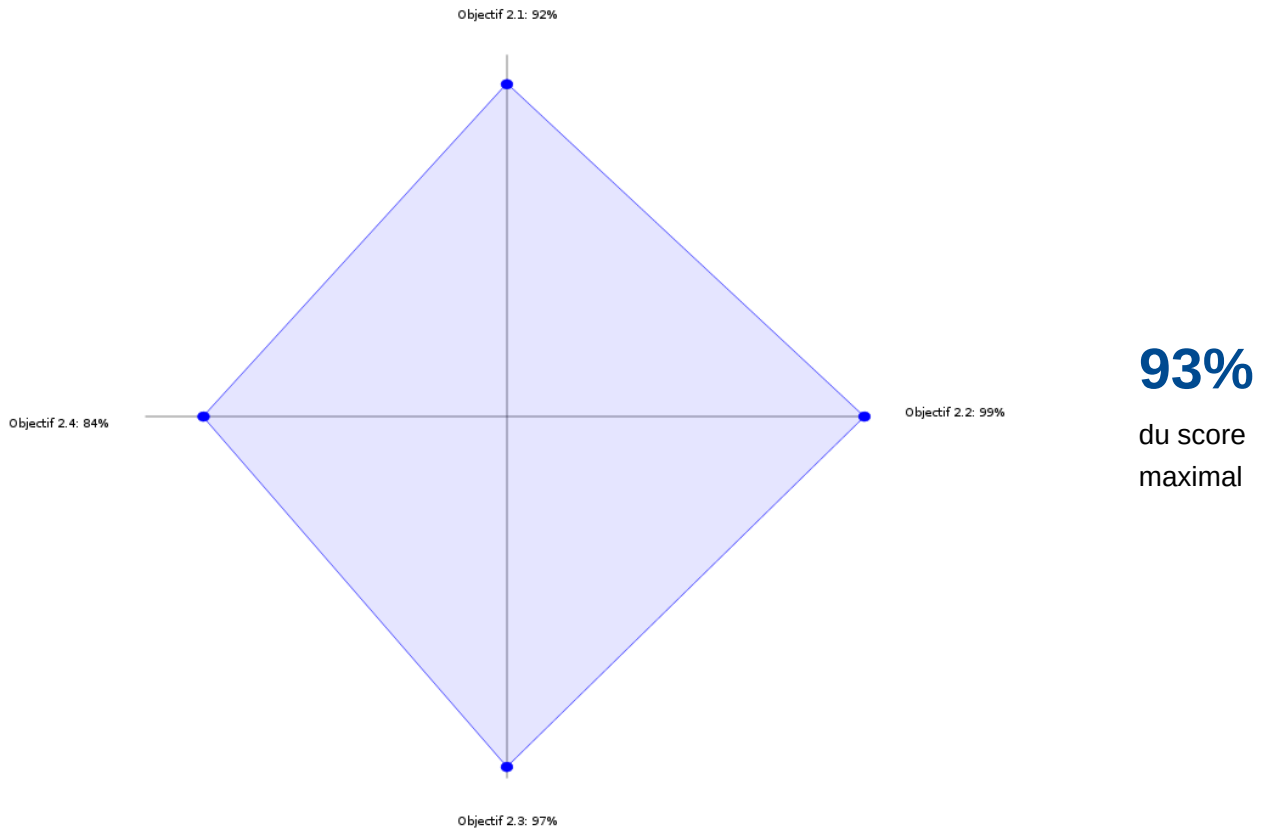


Objectifs		
1.1	Le patient est informé et son implication est recherchée.	88%
1.2	Le patient est respecté.	94%
1.3	Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient	97%
1.4	Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge	99%

La politique de l'Hôpital Trousseau / la Roche Guyon a induit une application et un respect des droits des patients dans tous les secteurs : maternité, pédiatrie et soins de suite et de réadaptation. Les comportements des professionnels permettent de respecter l'intimité des patients. Les chambres à deux lits sont équipées de paravents ou de rideaux de séparation. Sur le site de la Roche Guyon, il existe une salle commune recevant plusieurs enfants ayant des handicaps lourds au niveau neurologique, cette prise en charge est voulue et adaptée à la spécificité de ces patients. Pour les gestes où le respect de l'intimité est requis des paravents sont installés. Sur les deux sites, les locaux sont adaptés d'une façon générale aux différents types de handicaps et permettent la libre circulation des enfants à mobilité réduite. Les enfants, les parents et les futures parturientes sont informés par les professionnels, le livret d'accueil et des livrets adaptés aux enfants. Les diverses chartes

et informations sont affichées et sont en adéquation avec le type de prise en charge. L'implication du patient est recherchée pendant le parcours de soins. Les enfants en fonction de leur âge expriment leur consentement sur leur projet de soins et ses modalités. Le projet de naissance est exprimé et retrouvé. La traçabilité de l'information du patient (en fonction de l'âge) et des parents est retrouvée dans tous les dossiers ainsi que son implication dans le projet thérapeutique. Les parents sont fortement associés à la mise en œuvre du projet. Les coordonnées et le nom de la personne de confiance et de la personne à informer sont systématiquement retrouvés dans les dossiers de la maternité. Les respects de la dignité et de la confidentialité du patient sont assurés par les professionnels pendant tout le parcours du patient y compris pendant les transports et les gestes techniques. Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge et notamment pour le maintien de la continuité scolaire. Lors de situation sociale complexe et lorsque le foyer est dysfonctionnel, le service avec l'aide de l'ASE recherche la meilleure solution pour la réussite du projet de soins de l'enfant comme la demande d'admission en SSR spécialisé, en HAD ou à domicile. Lors de l'hospitalisation complète, le maintien de la scolarisation est recherchée grâce à l'école hospitalière. Des éducatrices (association) permettent aux enfants de se distraire dans des espaces dédiés en fonction de leur âge. Une animatrice du réseau RIFHOP contribue à la coordination parcours de soins du diagnostic jusqu'à la fin des traitements et en fin de vie, tout en favorisant le respect du projet familial. Les membres du réseau sont associés aux staffs médico-soignant de même que les IDE coordinatrices HAD afin de faciliter les transmissions d'information et les prises de décision. Les services de pédiatrie sont adaptés à la prise en charge de l'enfant. La présence parentale est facilitée et souhaitée. En phase de transition adolescent-adulte, les équipes pédiatriques et adultes se coordonnent pour assurer la continuité de la prise en charge du patient notamment par la mise en place de consultations conjointes. La prise en charge globale de l'environnement de l'enfant est prise en compte. L'accompagnement psycho-social de la mère et de l'enfant est mis en œuvre. Au niveau de la maternité, un projet de naissance est discuté entre les parents et l'équipe soignante. Une grande attention est portée au soutien des parents (lit accompagnant, maison des parents, salon des parents...) y compris à la place de la fratrie. Les associations sont souvent sollicitées pour financer un projet à court terme cher à l'enfant (sortie à Disneyland, WE en famille en Normandie...). Lorsque la décision de soins palliatifs est prise, il est tenu compte de la volonté du lieu choisi pour accompagner la fin de vie (modifiable à tout moment) et si le choix de l'hospitalisation est fait, la chambre peut être adaptée pour permettre d'une part aux deux parents de rester dormir ou d'accueillir un frère ou une sœur plus facilement. Le régime alimentaire est adapté pour permettre d'offrir à l'enfant ce qui lui fait plaisir. Lorsque la fin de vie est décidée, un courrier de non réanimation est intégré dans le DPI et transmis aux différents intervenants extérieurs y compris au SAMU. La volonté de l'enfant est prise en compte par l'équipe dans ses décisions de façon adaptée et les parents régulièrement informés des évolutions. Aux urgences, les temps d'attente moyens sont communiqués par l'infirmière d'accueil et/ou l'infirmier de coordination. L'établissement met en œuvre une politique pour limiter les contentions. Cependant, la réévaluation n'est pas toujours tracée sur le site de la Roche-Guyon La recherche de la satisfaction est effectuée par e-satis mais le nombre de réponses n'est pas optimal pour exploiter la prise en compte du point de vue des patients L'avis des représentants des usagers est pris en compte notamment pour la mise en place d'actions d'amélioration. Les représentants sont généralement connus par les professionnels mais pas toujours par les parents où les patientes de la maternité. Ces dernières ne sont pas informées sur les modalités pour effectuer des directives anticipées. La douleur du patient est évaluée régulièrement et prise en charge avec un traitement adapté. L'utilisation du protoxyde d'azote est utilisée pour tous les « petits » gestes douloureux. Un comité de lutte contre la douleur apporte des éléments spécifiques à la prise en charge de la douleur chez l'enfant si nécessaire. Néanmoins, il a été constaté que quelques prescriptions d'antalgiques (2/21) « si besoin » n'étaient pas étayées sur la base d'une échelle d'évaluation . Une action de sensibilisation sur ce dernier point a été engagée par l'établissement.

Chapitre 2 : Les équipes de soins



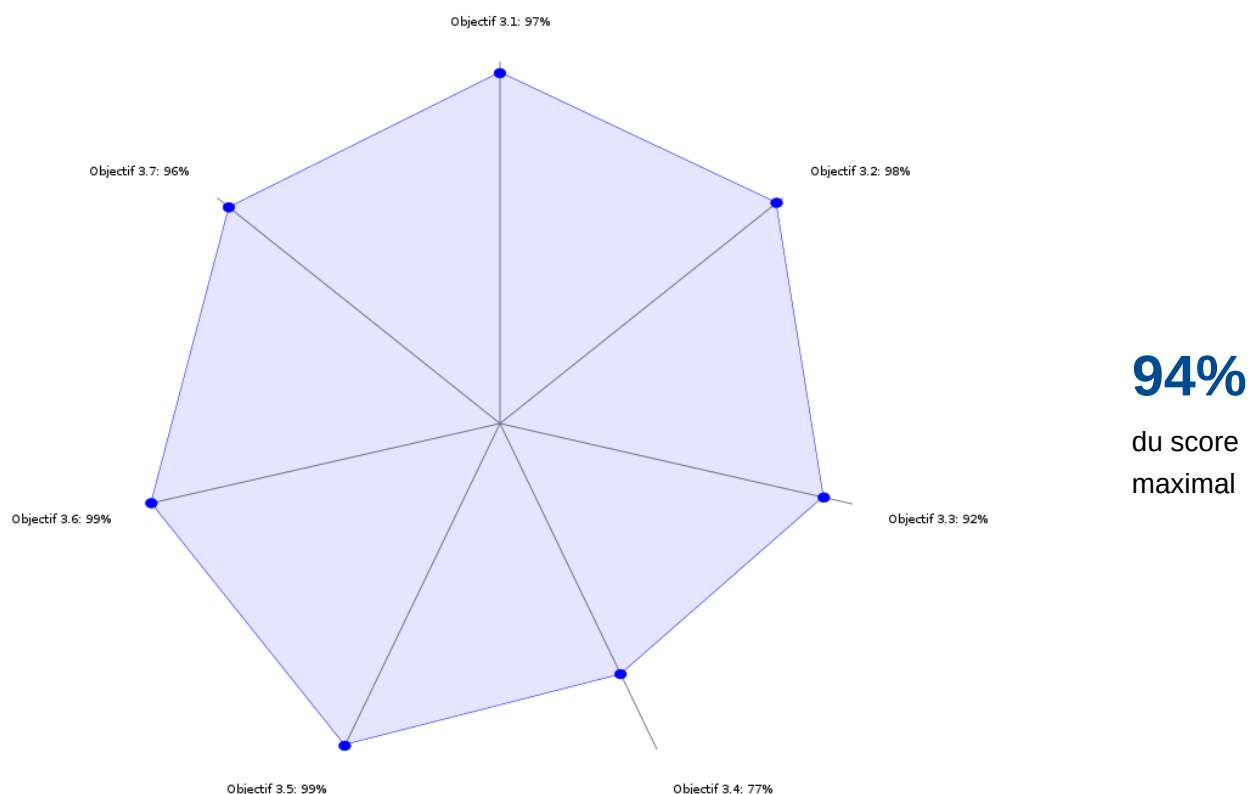
Objectifs		
2.1	La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l'équipe	92%
2.2	Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge	99%
2.3	Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques	97%
2.4	Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle	84%

L'Hôpital Trousseau / la Roche-Guyon prend en charge des enfants sur les filières de Médecine, chirurgie et de soins de réadaptation. Un secteur d'obstétrique complète le dispositif. Des hôpitaux de jour et des secteurs d'ambulatoire participent à la prise en charge. Le parcours du patient est coordonné afin de garantir la qualité et la sécurité des soins. La prise en charge des patients est multi professionnelle : La traçabilité de la coordination et de l'ensemble des professionnels est retrouvée dans les dossiers des enfants ou des parturientes. Les décisions thérapeutiques sont argumentées. Les R.C.P. sont organisées et leur traçabilité est retrouvées dans les dossiers. La pertinence des parcours est évaluée, en soins critiques et dans quelques secteurs l'évaluation d'une ré hospitalisation non prévue dans les 48h00 est effectuée en réanimation. Cependant, les revues de pertinence ne sont pas développées sur l'ensemble des services. Des staffs pluri disciplinaires sont organisés.

De nombreuses équipes transversales de support apportent leur expertise dans la prise en charge des enfants : Douleur, soins palliatifs, maltraitance,... L'analyse de la pertinence des produits sanguins labiles n'est pas régulièrement réalisée au sein des services. L'établissement a mis en place une lutte contre les infections nosocomiales notamment par les interventions de l'équipe d'hygiénistes et par la participation aux campagnes de vaccinations. L'ensemble des équipes connaît sa consommation de solution hydro alcoolique. Les locaux intermédiaires contenant des déchets à risque infectieux (DASRI) sont tous verrouillés. La lutte contre l'antibiorésistance est organisée notamment par une réévaluation de la prescription entre 48 et 72h00. Ces réflexions sont retrouvées dans la majorité des dossiers. La prise en charge médicamenteuse respecte généralement les règles de bonnes pratiques. Les prescriptions sont dans la plupart des services informatisées. Cependant, dans des unités (réanimation, hôpital de jour,...) où elles restent manuscrites, on ne retrouve pas toujours la signature du médecin et la prescription en D.C.I.. Elles sont validées par les pharmaciens pour la chimiothérapie. Les comprimés ou gélules sont tous correctement identifiés. L'administration des médicaments est effectuée par les infirmières qui vérifient la prescription et tracent l'administration (ou la non administration) sur informatique ou papier en temps réel. Les médicaments à risque sont connus des professionnels. Ils sont étiquetés de façon spécifique et rangés à part dans la pharmacie. Une liste de ces molécules par service est établie et affichée. La vérification des péremptions est régulière et tracée. En chirurgie, le dossier patient est informatisé à l'exception de la partie anesthésie qui est papier. Au retour du bloc, les IDE préviennent l'interne s'il y a des prescriptions à informatiser et en attendant, elles suivent les prescriptions imprimées en SSPI et tracent l'administration papier. Cependant, lorsqu'il y a des chimiothérapies à effectuer en urgence, le week-end, les médicaments sont fournis par le pharmacien et les préparations (reconstitution des cytostatiques) sont effectuées par les infirmières. L'établissement a pris connaissance du risque et doit mettre en place une formation à la reconstitution des cytostatiques par les internes en pharmacie avec une double vérification comme cela est déjà organisé sur les autres établissements de l'AP-HP recevant de la pédiatrie. En hématologie, la prescription médicamenteuse se réalise sur un outil informatique différent du DPI de l'établissement (réflexion pour intégration en cours). Le médecin imprime sa prescription et la met dans le dossier du jour du patient. En cas de modification, le médecin doit le préciser dans un encart prévu à cet effet et il est indiqué que l'IDE vérifie la concordance entre la prescription papier et informatique (double support). Les examens de radiologie font tous l'objet d'un compte rendu sur lequel la quantité de dose de rayonnement ionisant est reportée sauf lorsqu'il s'agit d'un examen fait avec un appareil portatif. Le dossier patient est généralement informatisé, il reste papier pour quelques services dont la réanimation. Il contient tous les éléments nécessaires à la prise en charge : Recueil de données, antécédents, allergies, motifs d'hospitalisation, traitement, comorbidités, résultats de bilans, personne de confiance. Tous les intervenants tracent leurs actions thérapeutiques ou préventives (Kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute, assistante sociale...). La sortie est organisée en amont avec l'équipe. Les réunions de coordination font l'objet d'un compte rendu dans le dossier. Le dossier informatisé et les C.R. de sortie sont accessibles à l'ensemble des praticiens dont ceux des urgences. Les transports intra hospitaliers sont effectués avec du matériel adapté. Ils respectent les règles d'hygiène, de confort et de respect de l'intimité des patients. Au niveau de la maternité, de nombreux indicateurs qualité et sécurité des soins sont suivis. Une salle césarienne est disponible, l'équipe de la maternité maîtrise le risque de l'hémorragie du post-partum. Les urgences disposent de circuits appropriés au type d'urgence. Des indicateurs de temps de passage sont suivis. La coordination entre les urgences et les équipes des services de soins sont en place. De nombreux protocoles communs de prises en charge sont mis en place comme par exemple pour la drépanocytose. L'environnement au bloc opératoire est conforme en matière de propreté, d'hygiène et de maîtrise du risque infectieux. Les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs sont maîtrisées par les équipes. Au bloc opératoire la check-list « sécurité patient », est réalisée. Néanmoins, il n'y a pas eu d'évaluation des « go et no go ». La sortie du patient est organisée en fonction de son autonomie et en lien avec l'aval qui est dans la plupart du temps destinataire le jour même d'une fiche de liaison de sortie ou d'un compte rendu complet. Cependant, la remise de la fiche de liaison n'est pas exhaustive, par exemple en ambulatoire des patients sortent uniquement avec leur compte rendu

opératoire et une ordonnance, le compte rendu d'hospitalisation est envoyé plus tard. Les indicateurs qualité et sécurité des soins et le taux de satisfaction globaux sont suivis et connus par les professionnels. Des Revues de Morbi Mortalité et des R.C.P sont effectuées. Il existe des retours d'expérience dans tous les services cependant la recherche des causes profondes des événements indésirables avec une méthode validée n'a pas été décrite par tous les services . Des audits sur l'hygiène, la tenue du dossier, ... sont effectués et suivis de plans d'actions. Néanmoins, l'exploitation de la satisfaction et de l'expérience des patients n'est pas développée.

Chapitre 3 : L'établissement



Objectifs		
3.1	L'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire	97%
3.2	L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement	98%
3.3	La gouvernance fait preuve de leadership	92%
3.4	L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences	77%
3.5	Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance	99%
3.6	L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté	99%
3.7	L'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins	96%

I - Au niveau du Groupe Hospitalier Sorbonne Université (GH.SU) Les 39 établissements qui constituent l'APHP sont regroupés en six GHU (Groupement Hospitalo-Universitaire), dans lesquels sont définis des DMU (Département Médico-universitaire) multi-sites en remplacement des pôles. Le GHU Sorbonne Université, constitué des hôpitaux Charles-Foix, Pitié-Salpêtrière, Rothschild, Saint-Antoine, Tenon et Trousseau - La

Roche-Guyon, comporte 13 DMU. Les GHU ont été définis avec les doyens des universités selon les filières universitaires, en concordance avec les parcours et les prises en charge des patients. Le cadre général et les orientations stratégiques sont donnés par le siège de l'APHP. Ainsi, les objectifs pour la période 2021-2025 sont recensés dans le projet d'établissement de l'AP-HP qui comprend le projet médical, le projet de soins et le projet qualité Gestion des Risques. Il existe une Commission Centrale de Concertation avec les Usagers (3CU), composé de représentants des usagers de l'ensemble des GHU. Chaque GHU décline ensuite ses politiques dans son propre projet d'établissement pour la période 2021-2025, en cohérence avec les orientations de l'APHP, selon les besoins de son territoire. L'AP-HP est dérogatoire au droit commun et ne constitue pas l'établissement support des GHT d'Ile-de-France. Les GHU ont des conventions d'association avec les GHT. Le GHU Sorbonne Université a ainsi des conventions d'association avec les GHT 77 Nord et GHT 77 Sud. La coordination avec la ville est un axe majeur pour le GHU Sorbonne Université. Des admissions directes sont possibles notamment sur des parcours complexes pour éviter les passages aux urgences, et une concertation est mise en place avec les professionnels de ville ou les acteurs sociaux comme le SAMU Social. 20 à 30% des admissions sont réalisées directement du domicile du patient ou de l'EHPAD vers les services de gériatrie aigue, de SSR ou de psychiatrie du GHU. Différentes équipes mobiles hospitalières sont déployées sur les secteurs de ville, EHPAD ou sur les établissements de santé en gériatrie, MPR, santé mentale, périnatalité, appui aux parcours... Une collaboration est développée avec les CPTS et les médecins libéraux. Cette coordination est appuyée par une politique de ressources humaines médicales à destination des territoires sous-denses, avec 24 postes de médecins partagés sur des spécialités médicales, et 61 postes partagés sur différents établissements d'Ile de France. La psychiatrie est un autre axe prioritaire du GHU Sorbonne Université, qui propose une prise en charge sur la vie entière à destination des enfants, des adolescents et des adultes jusqu'à la géronto-psychiatrie. Le GHU est par ailleurs une référence dans la prise en charge de l'autisme : diagnostic, prise en charge enfants, adolescents et adultes, équipe mobile, formations des professionnels de ville, et USIDATU (Unité Sanitaire Interdépartementale d'Accueil Temporaire d'Urgence) à compétence régionale. Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est mis à jour quotidiennement par une équipe de régulation, qui alerte de la gouvernance en cas de tension. Une équipe médico-soignante assure l'appui de la fluidification des parcours des patients, en lien avec les structures HAD et de ville, et les acteurs institutionnels (ARS, conseil local de santé de la ville de Paris, justice, etc.). Le GHU Sorbonne Université est un groupement de référence dans la prise en charge des patients en situation de handicap avec la création d'une prise en charge spécifique « Handi-consult » pour les patients en échec de prise en charge en ville, ainsi que dans la prise en charge des patients malentendants à l'UNISS. La télé-expertise a été particulièrement développée durant la crise sanitaire, notamment en cardiologie, en diabétologie ou en hépatologie (jusqu'à 30% de l'activité). L'engagement du patient est un axe du projet stratégique du GHU Sorbonne Université, en lien avec le projet d'établissement de l'AP-HP. L'établissement s'emploie à développer l'écoute envers les patients afin d'améliorer les organisations. L'expertise patient est quant à elle impulsée par l'université des patients, délivrant des DU et master class formant les patients experts. A ce jour, environ 350 patients ont été formés. Des enseignements dirigés pour les étudiants en médecine sont dispensés par un médecin accompagné d'un patient. Les représentants des usagers sont impliqués dans le management du GHU, en lien avec la gouvernance, sur les quatre axes du projet des usagers. Ils sont déclinés sur chaque établissement et suivis en Commission Des Usagers : information du patient, écoute et prise en considération du patient, hospitalité empathique, accompagnement en cas de vulnérabilités. Plusieurs cafés du rétablissement permettent des échanges entre des patients rétablis avec des patients en cours de prise en charge. La promotion de la bientraitance est un engagement de la gouvernance du GHU Sorbonne Université, inscrite dans le projet de soins et le projet qualité 2021-2025. Elle se décline dans le projet de soins du patient qui se veut individualisé, la mise en place de réunions pluridisciplinaires, l'évaluation de la satisfaction du patient (e-satis, suivi des réclamations, patients-traceurs, questionnaires, Verbatim...), la mise en place d'une commission de support éthique dans chaque établissement, l'amélioration des conditions hôtelières. Le GHU s'est engagé dans la démarche Label Hospitalité, fondée sur la perception de l'utilisateur. Près d'une centaine de

label Hospitalité ont été décernés sur le GHU Sorbonne Université. Le GHU met en place des outils dédiés au dépistage de la maltraitance en pédiatrie et chez l'adulte, qui permettent l'identification des situations complexes avec implication des aidants. Le DMP et l'espace numérique en santé sont alimentés (lorsque l'usager en a ouvert) directement par le dossier patient informatisé pour 98% des documents émis. La qualité et gestion des risques est intégrée dans le projet d'établissement et déclinée dans les différents projets. Les objectifs sont établis au niveau des services de soins, avec une contractualisation au niveau des DMU et un suivi annuel en conférence stratégique. Le pilotage de la démarche qualité s'appuie sur un réseau de professionnels, les comités et commissions des vigilances. La Qualité Gestion des Risques est déclinée au sein des DMU par établissement et services. La gestion documentaire est unique pour l'ensemble du GHU. Des binômes référents Qualité Risques et cadre supérieur de santé sur chaque hôpital du GHU permettent l'animation de la démarche qualité au sein des services par l'intermédiaire de réunions, de rencontres de professionnels médicaux et non médicaux au niveau de l'établissement et du DMU. Une démarche d'accréditation d'équipe des secteurs d'imagerie est en cours sur le GHU Sorbonne Université. Les démarches d'évaluation sont organisées sous forme d'audits (armoires à médicaments, bracelet d'identification, chariots d'urgence, check-list au bloc opératoire...). La dynamique a été freinée par la crise COVID mais l'impulsion est reprise notamment par la préparation des visites de certification. Des actions d'amélioration des pratiques ou des prises en charge des patients peuvent faire l'objet d'une prime d'engagement collectif, ou bénéficier de financements spécifiques dans le cadre d'appels à projets financés par l'AP-HP (fonds APRES). Les plans des Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE) sont déclinés par établissement, et font l'objet d'exercices réguliers. Une commission SSE au niveau du GHU est en cours de constitution. La stratégie relative au développement durable est définie pour la période 2021-2025. Elle se décline en actions de sensibilisation auprès des professionnels (sur les maternités, perturbateurs endocriniens, tri des déchets). Le GHU a analysé son bilan carbone à deux reprises, la dernière fois en 2022. Des actions spécifiques ont été menées comme l'arrêt de l'utilisation de gaz avec impact carbone important aux blocs opératoires. Des actions sont également menées afin d'économiser les énergies (récupération des eaux de pluie, mise en place d'énergies renouvelables comme une chaufferie avec biomasse). La sécurisation du système d'information est organisée avec changement régulier des mots de passe, une revue régulière des accès, la sécurisation d'internet, une charte d'utilisation du système d'information. L'ensemble des médecins est incité à utiliser la messagerie sécurisée MSSanté dans le cadre de ses relations avec les professionnels de ville et les autres établissements. La politique QVT portée par la gouvernance est basée sur le dialogue, avec des actions sur les services de soins afin d'être porteur de sens. En 2021, Sorbonne Université a conduit un travail majeur visant à diffuser une culture QVT au sein du groupe hospitalier, faisant figure de pilote pour les autres établissements de l'AP-HP. Un COPIL QVT, co-présidé par la Directrice Générale du groupe hospitalier et le président de la commission médicale d'établissement locale, a défini un plan d'action reprenant les propositions faites par un groupe de travail rassemblant des managers médecins et paramédicaux. Ainsi, 6 axes (management ; temps d'échange formels et informels au sein des services ; diffusion de l'information ; intégration ; harmonisation des organisations et des pratiques ; bien-être) et 56 actions concrètes ont été définies et se déclinent dans le cadre du projet d'établissement. Des référents QVT relaient les différentes actions menées au sein de chaque DMU. Les actions de formation en management pour les professionnels médicaux comme paramédicaux sont renforcées, comme par exemple le coaching. Elles bénéficient notamment aux nouveaux responsables afin qu'ils puissent développer leur leadership. Pour les nouveaux professionnels, médicaux et non médicaux, des temps d'accueil et d'intégration sont prévus, notamment à des fins de fidélisation. Le groupe hospitalier s'emploie à développer une politique de détermination des cibles en emploi et effectifs pour tous les services et tous les métiers (maquettes organisationnelles et tableaux de service ; gestion prévisionnelle des effectifs ; gestion du temps de travail et temps de présence au travail). La gestion du remplacement des absences passe par une mutualisation des compétences et le redéploiement des professionnels au sein de chaque site et de chaque DMU. Concernant les RPS, de nombreux dispositifs sont à la disposition des professionnels, qui peuvent par ailleurs s'appuyer sur des instances dédiées (par exemple, la commission médicale de Vie

Hospitalière pour les médecins). La politique RH donne un certain degré de délégation de gestion aux DMU, via le plan de formation et la promotion professionnelle. Des outils d'évaluation de la charge de travail et des organisations adaptées sont mis en œuvre, pouvant aboutir à des audits. Le travail en équipe est promu. Une expérimentation PACTE a été menée en 2015 sur deux établissements (hôpitaux Tenon et Saint Antoine) mais n'a pas été poursuivie.

II - Au niveau du l'hôpital Trousseau/La-Roche-Guyon L'hôpital Trousseau / La Roche Guyon est un hôpital de proximité, axé sur la filière pédiatrique et obstétrique. L'établissement collabore également avec l'ensemble des hôpitaux pédiatriques de l'AP-HP et est notamment support pour des établissements très éloignés pour la mise en place, le transport et la prise en charge d'enfants ayant besoin d'un traitement par ECMO (oxygénation par membrane extra corporelle). L'établissement est aussi référent pour la prise en charge de maladies rares touchant les enfants. L'établissement s'emploie à développer l'écoute des patients afin d'améliorer les organisations. Cependant, le peu de réponses aux questionnaires de satisfaction (E.Satis) a induit le site à envisager de développer de nouvelles enquêtes de satisfaction sur le terrain. L'expertise patient est en cours de développement et déjà intégré dans des programmes ou des actions d'éducatons thérapeutiques notamment la dialyse par exemple. Les représentants des usagers de l'hôpital Trousseau / La-Roche-Guyon sont intégrés en son sein et bénéficie d'une écoute de la direction. Les actions qu'ils préconisent sont mises en œuvre même si parfois elles sont réalisées avec un certain délai. Les coordonnées des représentants des usagers sont affichées et diffusées. Cependant, quelques patients interrogés ne les connaissaient pas. Les représentants des usagers sont impliqués dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge notamment par la participation à des audits et à l'analyse des plaintes et la prise de connaissance des déclarations d'événements indésirables. La promotion de la bientraitance est un engagement de la gouvernance du GHU Sorbonne Université et de celle de l'hôpital Trousseau/La Roche-Guyon. Elle est inscrite dans le projet de soins et le projet qualité 2021-2025. Le GHU met en place des outils dédiés au dépistage de la maltraitance. En pédiatrie, une équipe dédiée et mobile sur Trousseau/ la Roche-Guyon peut être appelée pour son expertise et aider les équipes et les victimes. Des démarches d'évaluation ont été organisées sous forme d'audits et de traceurs. La culture du signalement est promue au sein de l'établissement, cependant le nombre de déclarations d'événements indésirables liés aux soins est faible. Les plans des Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE) sont déclinés par l'établissement, et font l'objet d'exercice. Une commission SSE au niveau du GHU est en cours de constitution. Sur le site de Trousseau/La Roche-Guyon, le Plan Blanc est formalisé et connu par les professionnels. La prise en charge des urgences vitales est organisée avec trois numéros d'appel (pédiatrie, obstétrique, adulte) affichés en salle de soins et sur les téléphones. Les formations des professionnels et le suivi des mises à jour sont effectifs, de plus des exercices de simulation sur la prise en charge des urgences vitales sont organisées au sein des services. Les chariots d'urgence sont régulièrement vérifiés. La stratégie relative au développement durable est définie pour la période 2021-2025. Elle se décline en actions de sensibilisation auprès des professionnels (sur les maternités, perturbateurs endocriniens, tri des déchets). Le GHU a analysé son bilan carbone à deux reprises, la dernière étant en 2022. Des actions spécifiques ont été menées comme l'arrêt de l'utilisation de gaz avec impact carbone important aux blocs opératoires. Sur le site de Trousseau/La Roche-Guyon, une démarche développement durable sur le bloc opératoire est particulièrement avancée. La sécurisation du système d'information est organisée avec changement régulier des mots de passe et des solutions dégradées en cas d'attaque informatique. Les professionnels connaissent cette solution et l'ordinateur (réplique des dossiers informatisés) à utiliser en cas de panne du système. Cependant l'ensemble des professionnels n'utilise pas une messagerie sécurisée. Suite à la crise COVID, l'hôpital Trousseau/La Roche-Guyon a des postes vacants notamment pour les IDE conduisant à la fermeture de lits.

Table des Annexes

- Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche
- Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2022
- Annexe 3. Programme de visite

Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	750712184	ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PARIS	3 AVENUE VICTORIA 75184 PARIS CEDEX 04 FRANCE
Établissement géographique	950100024	HOPITAL DE LA ROCHE GUYON - AP-HP	1 RUE JUSTINIEN BLAZY 95780 La Roche-Guyon FRANCE
Établissement principal	750100109	HOPITAL ARMAND TROUSSEAU - AP-HP	26 AVENUE DU DR ARNOLD NETTER 75571 Paris Cedex 12 FRANCE

Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2022

Catégorie / Champs d'applicabilité / Donnée de profil	Valeur
---	--------

Annexe 3. Programme de visite

Nb	Méthode	Sous-méthode	Champs d'applicabilité	Description traceur
1	Traceur ciblé	Circuit du médicament et des produits de santé		Circuit PECM
2	Parcours traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Maladie chronique Soins de suite et réadaptation Hospitalisation complète Programmé	
3	Audit système	Entretien Professionnel		
4	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Patient en situation de précarité Soins de suite et réadaptation Hospitalisation complète Programmé	
5	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Enfant et adolescent Médecine Pas de situation particulière Programmé	
6	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Maladie chronique Médecine Hospitalisation complète Programmé	

7	Audit système	Entretien Professionnel		
8	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Urgences Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète	
9	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		IAS - Précautions standards et complémentaires
10	Audit système	Entretien Professionnel		
11	Traceur ciblé	Gestion des événements indésirables graves		EIG ayant fait l'objet d'une déclaration à l'ARS ou d'un CREX en interne
12	Parcours traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
13	Audit système	Entretien Professionnel		
14	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		IAS - Précautions standards et complémentaires
15	Traceur ciblé	Transport intra-hospitalier des patients		Transport - Patient assis imagerie médicale
16	Parcours traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Pas de situation particulière	

			Programmé	
17	Parcours traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Urgences Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète	
18	Traceur ciblé	Gestion des évènements indésirables graves		EIG ayant fait l'objet d'une déclaration à l'ARS ou d'un CREX en interne
19	Traceur ciblé	Gestion des produits sanguins labiles		Priorisation de l'unité de soins où est réalisée la transfusion / Le type de produit est laissé à l'appréciation de l'EV
20	Traceur ciblé	Circuit du médicament et des produits de santé		Médicament à risque - injectable ou per os
21	Patient traceur		Tout l'établissement Maternité Urgences Adulte Pas de situation particulière Hospitalisation complète	
22	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Médecine Hospitalisation complète Programmé	
23	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Enfant et adolescent Maladie chronique Médecine	

			Programmé	
24	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		IAS - Précautions standards et complémentaires
25	Audit système	Représentants des usagers		
26	Audit système	Entretien Professionnel		
27	Traceur ciblé	Transport intra-hospitalier des patients		Transport entre le secteur de soins et le bloc - Patient couché
28	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		IAS - Précautions standards et complémentaires
29	Traceur ciblé	Circuit du médicament et des produits de santé		Médicament à risque - injectable ou per os
30	Parcours traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Soins critiques Médecine Hospitalisation complète Programmé	
31	Parcours traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Maladie chronique Médecine Hospitalisation complète Programmé	
32	Audit système	Entretien Professionnel		
33	Audit système	Entretien Professionnel		
	Traceur	Circuit du		Médicament à risque –

34	ciblé	médicament et des produits de santé		chimiothérapie
35	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Médecine Programmé	
36	Audit système	Dynamique d'amélioration		
37	Audit système	Maitrise des risques		
38	Audit système	Entretien Professionnel		
39	Audit système	Entretien Professionnel		
40	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Patient atteint d'un cancer Médecine Hospitalisation complète Programmé	
41	Patient traceur		Tout l'établissement Adulte Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
42	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Pas de situation particulière Programmé	

43	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Soins de suite et réadaptation Hospitalisation complète Programmé	
44	Patient traceur		Tout l'établissement Maternité Adulte Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
45	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Maternité Adulte Pas de situation particulière Programmé	
46	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Soins critiques Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
47	Patient traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
48	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		IAS - Précautions standards et complémentaires

49	Traceur ciblé	Accueil non programmé		Urgences
50	Patient traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
51	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
52	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Pas de situation particulière Programmé	
53	Patient traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Hospitalisation complète Programmé	
54	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Soins critiques Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
			Tout l'établissement	

55	Parcours traceur		Enfant et adolescent Soins critiques Urgences Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète	
56	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Pas de situation particulière Programmé	
57	Parcours traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Soins critiques Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
58	Parcours traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Maternité Maladie chronique Soins critiques Adulte Médecine Hospitalisation complète Programmé	
59	Traceur ciblé	Circuit du médicament et des produits de santé		Antibiotique injectable ou per os

60	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Urgences Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète	
61	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Pas de situation particulière Programmé	
62	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Enfant et adolescent Patient atteint d'un cancer Médecine Programmé	
63	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Enfant et adolescent Maladie chronique Médecine Programmé	
64	Parcours traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Enfant et adolescent Patient atteint d'un cancer Médecine Hospitalisation complète Programmé	
			Tout l'établissement	

65	Parcours traceur		Enfant et adolescent Maladie chronique Médecine Hospitalisation complète Programmé	
66	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
67	Parcours traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Soins critiques Urgences Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète	
68	Traceur ciblé	Prélèvement et greffe d'organes et de tissus		NA
69	Audit système	Engagement patient		
70	Audit système	Coordination territoriale		
71	Audit système	Leadership		
72	Audit système	QVT & Travail en équipe		
73	Audit système	Entretien Professionnel		
	Patient		Tout l'établissement Enfant et adolescent Maladie chronique	

74	traceur		Médecine Hospitalisation complète Programmé	
75	Parcours traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	

Retrouvez tous nos travaux sur
www.has-sante.fr

